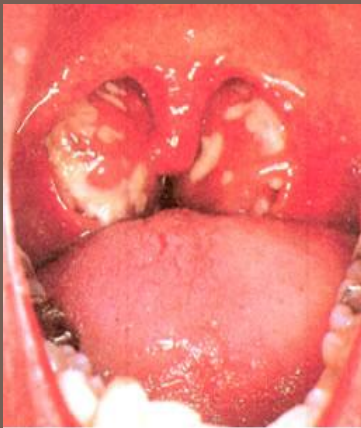




LA DIPHTÉRIE

Dr : BERBADJ.M
HMRUC

I/ INTRODUCTION:

- Toxi-infection contagieuse, peu immunisante, redoutable, maladie grave à déclaration obligatoire, évoquée devant **toute angine à fausses membranes.**
- Doit sa gravité :
 - Au risque d'extension des fausses membranes aux voies respiratoires entraînant l'asphyxie par obstruction.
 - Et surtout à la toxine produite par la bactérie responsable de désordres vitaux à distance (complications myocardique et neurologique).
- Urgence dg, thérapeutique et épidémiologique.



DIPHTERIA =

FAUSSES MEMBRANES

II/EPIDEMIOLOGIE:



□ A/ Agent causal:

- **Corynebacterium diphtheriae** : bacille à gram positif (bacille de Klebs – loeffler).
- Se disposent sous forme de **bâtonnets** en forme de palissades.
- Seules les souches porteuses du **gène de la toxine (tox+)** produisent la toxine responsable des manifestations cardiaques et neurologiques.

II/EPIDEMIOLOGIE:

□ **b) Réservoir :**

➤ L'homme est le seul réservoir de **Corynebacterium diphtheriae**

- Malades

- Convalescents

- et Porteurs asymptomatiques

II/EPIDEMIOLOGIE:

C/ Transmission:

Interhumaine, essentiellement par voie aérienne :

Les **gouttelettes de pflugge**

D/ Modalités Epidémiologiques

- la maladie sévit a l'état **endémo-épidémique**, devenue moins fréquente avec la généralisation de la vaccination qui reste insuffisante dans la population adulte.
- L'Algérie a connu des épidémies:
1993 : 296 cas, 1994 : 996 cas, 1995 : 1060 cas, 1996 : 107 cas
- L'absence d'éradication de cette maladie dans notre pays voire le maintien de foyers épidémiques sont dues essentiellement à la baisse de l'immunité chez les adultes du fait de l'absence de rappels vaccinaux.

III/Physiopathologie:

- Après pénétration par voie respiratoire, *Corynebacterium diphtheriae*, se multiplie au niveau du nasopharynx provoquant:
 1. les **fausses membranes extensives** avec risque d'obstruction.
 2. produit la **toxine** qui se fixe sur les cellules nerveuses ,myocardiques et rénales et exerce son pouvoir pathogènes = manifestations cliniques toxiniques.

IV/Clinique:

A-Type de description :

Angine diphtérique commune de l'adulte non vacciné

- **Incubation**: courte 2 à 7j, silencieuse
- **Invasion**: début est **progressif** avec :
 - .fébricule 38-38.5, malaise général
 - .Dysphagie modérée
 - A l'examen : amygdales peu tuméfiées recouvertes d'une ou plusieurs taches opalines.

IV/Clinique:

□ Phase d'état :

Atteinte rapidement en 2à3 jours caractérisée par les :

fausses membranes



enduit épais, brillant, blanc nacré à bords nets bordé d'un liseré rouge.

- Ces fausses membranes sont **bilatérales ,adhérentes, cohérentes, extensives, se reproduisent** rapidement après leur arrachement et elles sont riches en corynébactéries.
- au niveau des **amygdales**, les **piliers** du voile du palais et la **luette** .

IV/Clinique:

- **Les signes fonctionnels** : toux laryngée, douleur sous maxillaire, dysphonie, dysphagie
- **Les signes généraux** : fièvre à 38, tachycardie, pâleur et fatigue intense (signes toxiques)
- **Les signes loco régionaux** :
 - Ecoulement nasal séreux ou muco-purulent avec érosion narinaire
 - Adénopathies sous angulomaxillaires **sans péri adénite.**

La règle:

Devant ce tableau, d'angine à fausses membranes :
le dg de diphtérie doit être évoqué conduisant à un
prélèvement de gorge et le début du traitement.

4-Evolution

□ Sous traitement

guérison en quelques jours ; disparition des fausses membranes et régression des signes toxiques.

Les complications:

locales

- **Diphtérie laryngée :**

Extension des fausses membranes au larynx (croup) avec asphyxie.

Les complications:

A distance

Toxiniques:

- ❑ **L'atteinte myocardique**
- ❑ **L'atteinte neurologique**
- ❑ **L'atteinte rénale**

L'atteinte myocardique:

- Elle débute **précocement** (10j), se manifeste par des troubles électriques : troubles de **conduction** et/ ou du **rythme** cardiaque avec risque permanent de décès brutal, nécessitant une surveillance électrocardiographique (ECG).

Le tableau peut aller jusqu'à l'insuffisance cardiaque aiguë, responsable de la plupart des décès:
(syndrome malin secondaire de Marfan).

Des séquelles tardives sont possibles

Syndrome malin secondaire de Marfan).

- -7j après le début de l'angine
- -grave ;risque d' arrêt cardiaque
- -impose une surveillance en unité de soins intensifs+++
- -début : vmt +paralysie du voile (reflux des aliment par le nez)
- -le symptôme essentiel : **la myocardite**: tachycardie ,troubles du rythme, cardiomégalie, hépatomégalie.
- -un syndrome hémorragique et une insuffisance rénale peuvent survenir.

L'atteinte neurologique :

Dominée par les **paralysies périphériques** qui grèvent le pronostic **tardivement** (syndrome malin tardif de Grenet et Mezart vers le 50ème jour).

Tb de polyradiculonévrites ascendante ,l'atteinte respiratoire impose la ventilation assistée.

Régressent sans séquelles.

- **Paralysies velopalatines précoces** (troubles de la phonation et de la déglutition avec rejet des aliments par le nez et fausses route)

A l'examen: voile flasque luvette est déviée

Annonciatrices de myocardite

- **Paralysie d'accommodation:** une pseudo-presbytie avec gêne de la vue de près.

L'atteinte rénale :

- Plus rare, elle associe **protéinurie, hématurie et insuffisance rénale oligo- anurique**

Exceptionnellement :

➤ Des complications systémiques:

- Arthrite purulente
- Endocardite
- Bactériémie

B- Formes cliniques :

□ Angine diphtérique maligne :

Fièvre 39-40°C, **AEG**, déshydratation, asthénie intense, pâleur, mêlée de cyanose, bouche fissurée saignante, jetage séro-sanglant.

- **Signes locaux de malignité**: haleine fétide, fausses membranes envahissant le pharynx, **grisâtres, hémorragiques**, reposant sur une muqueuse oedématisée et hémorragique.

Le cou est volumineux déformé par des adénopathies bilatérales douloureuses avec péri adénite (cou proconsulaire).

- **Signes Toxiniques** ++ : atteinte cardiaque, rénale, syndrome hémorragique.

L'évolution est fatale.

Formes cliniques:

- **Diphtérie laryngée ou croup** : peut être primitive d'emblée ,il évolue classiquement en trois phases :

.**La phase dysphonique** : **toux** devient **rauque** et la **voie s'éteint** progressivement

.**La phase dyspnéique** : (24-48H) : **extinction** de la **toux** et de la **voie** puis installation d'une **dyspnée laryngée** (inspiratoire avec sifflement, cornage, tirage).

.**La phase asphyxique** : s'installe en quelques heures entraînant une détresse respiratoire aiguë aboutissant à la mort rapide si une trachéotomie n'est pas pratiquée.

La laryngite diphtérique ou croup est une urgence thérapeutique

Formes cliniques:

□ 3 .Autres localisations :

Cutanée+++ , nasale, otite, conjonctivite, génitale...

V/Diagnostic :

□ **Les arguments cliniques et épidémiologiques :**

.Notion de contagé, absence de vaccination

.Fausses membranes, signes toxiques

□ **Les arguments par aciniques :**

Mise en évidence de la bactérie au niveau du

prélèvement de gorge à l'examen direct en

urgence+++ avec culture sur milieu de **Loeffler** et
identification du pouvoir toxigène(test d'ELEK)

PCR en urgence permet d'identifier le gène tox.

prélèvement de gorge

- Moindre doute
- Se fait à la périphérie des fausses membranes sur écouvillon sec.
- Acheminer aussitôt au laboratoire
- Le laboratoire doit être préalablement averti
- Examen direct en **urgence** à la recherche de **Corynebacterium diphtheriae**
- La culture confirme le dg

VI/Traitement :

1-Sérothérapie : le sérum antidiphtérique équin est administré en **urgence sur les données de l'examen direct** par voie **IM** .

La posologie est adaptée en fonction de la gravité:

20.000u (forme grave)

40.000u (forme maligne)

- Méthode : Besredka(épreuve de tolérance): risque de choc anaphylactique.

VI/Traitement :

2-Antibiothérapie :

Permet la suppression de la source des fausses membranes et de la production de la toxine.

Pénicilline G : 100.000U /kg/j

Amoxicilline : 3g/j (chez l'adulte)

100mg/kg/j(chez l'enfant) .

Voie veineuse puis relai per os

Durée : 14j

Si allergie : **macrolide** pendant 14j

□ **Azithromycine** 3à5j

VI/Traitement :

3-Mesures symptomatiques : +++

- **Isolement et immobilisation absolue** au lit
- **Corticoïdes** en cas de laryngite
- **Intubation/trachéotomie** si menace d'asphyxie
- **Traitement digitalo diurétique** (atteinte cardiaque).

VI/Traitement :

4-Vaccination : la diphtérie n'est pas une maladie immunisante

la vaccination par l'anatoxine diphtérique
est systématique

j1-j3-j15

VI/Traitement :

B) Préventif :

Malade :

Déclaration obligatoire

Isolement respiratoire jusqu'à négativation du prélèvement de gorge(2 prélèvements successifs réalisés après l'arrêt de l'antibiothérapie)

Un contrôle à j30 est recommandé.

Sujets contacts : dépistage

- ☐ Porteurs sains : antibiothérapie
- ☐ Sujets non vacciné : sérothérapie (5000ui) et débiter la vaccination

Vaccination : par l'anatoxine diphtérique (PEV)

3^{ème}, 4^{ème}, 5^{ème} mois, rappels 18 mois, 5 ans ,11-13 ans, chaque 10 ans.

Conclusion:

- ❑ Toxi-infection contagieuse, grave à déclaration obligatoire.
- ❑ Evoquée devant **toute angine à fausses membranes**
- ❑ Redoutable par ses complications **locales**(croup) et surtout **toxiques** qui entraînent des désordres vitaux à distance (myocardique et neurologique).
- ❑ **Urgence dg ,thérapeutique et épidémiologique+++**
- ❑ Peut être prévenue par la vaccination collective.

Le maintien de la protection immunitaire antidiphtérique chez les adolescents et adultes par les rappels/10 ans.